

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	急性冠心症 Acute Coronary Syndrome ; ACS				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-B07	CCU 林炳蓁	97 年 05 月 31 日	115 年 01 月 06 日	
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
	第 3.9 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解急性冠心症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

急性冠心症是冠狀動脈供氧和心肌需氧之間的暫時不平衡，只是在急性冠心症有效時間內發生缺血，並不會引起心肌的永久損傷。

（二）症狀

急性冠心症可分為兩種主要的類型。不穩定性(unstable)心絞痛或急性心肌梗塞，症狀為在休息或活動時出現的胸部疼痛或不適。胸痛症狀發作的次數增加，和疼痛的強度增加為特點。疼痛可以持續 15 分鐘以上，或難以被硝酸甘油酯(NTG)或休息所緩解。

（三）常見檢查

- 1.心電圖檢查(Electrocardiogram, ECG)。
- 2.心導管檢查(Cardiac cath exam)。
- 3.心肌血流灌注掃描(Perfusion scan)。
- 4.心臟超音波(Cardiac echo)。

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/8

5.640 切電腦斷層。

6.血清心肌酶(Cardiac enzyme & Troponine T)。

7.運動心電圖。

8.血脂濃度的測定。

(四) 常見治療

- 1.藥物治療：藥物之治療目的為降低心肌需氧量，及增加冠狀動脈血流量，以緩解心肌缺氧情況。包含硝酸甘油酯、乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、血小板抑制劑。
- 2.經皮冠狀動脈介入治療術(PCI)。
- 3.冠狀動脈血管支架置入術。
- 4.冠狀動脈粥狀硬化物刮除術(Coronary Atherectomy)。
- 5.冠狀動脈繞道手術(CABG)。

(五) 護理問題

- 1.疼痛不適/與冠狀動脈供血不良有關。
- 2.低心輸出量/與冠狀動脈供血不良導致組織灌流量減少有關。
- 3.活動耐力不足/與冠狀動脈供血不良、身體氧氣供需失衡導致疲倦有關。
- 4.易受傷害/與注射抗凝劑有關。

(六) 護理措施

- 1.疼痛不適/與冠狀動脈供血不良有關：
 - (1)評估病人的疼痛程度及特徵。
 - (2)評估疼痛加劇的原因。
 - (3)減少或排除疼痛的因素。
 - (4)教導深呼吸、背部按摩、冥想等放鬆技巧。
 - (5)提供音樂、書籍以轉移注意力。
 - (6)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。
 - (7)與病人及家屬共同討論可控制引發疼痛的因素之方法。
 - (8)依醫囑給予止痛劑。

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/8

(9)評估疼痛控制技巧的效果。

(10)評估藥物的效果及副作用。

(11)鼓勵家屬多予陪伴。

2. 低心輸出量\與冠狀動脈供血不良導致組織灌流量減少有關：

(1)監測記錄生命徵象，尤其是血壓變化，並報告醫師。

(2)急性期每 1-2 小時監測尿量及比重並記錄。

(3)監測每天的輸出入量並記錄。

(4)監測每日體重並記錄。

(5)監測血液尿素氮、肌酸酐、電解質濃度。

(6)監測血清 PH 值及血比容，需要時依醫囑給予補充。

(7)避免使用對腎臟功能產生毒性的藥物。

(8)評估末梢水腫程度，並保護水腫皮膚。

(9)教導病人如何護理及保護水腫皮膚的方法。

(10)病人因肺水腫有呼吸困難情形，適度給氧並報告醫師。

(11)提供飲食衛教，指導少量多餐或依醫囑限水，以維持身體需要。

(12)協助家屬及病人瞭解控制食物中鉀及蛋白質攝取的原因。

(13)注意能活動病人的安全，防意外發生，避免姿勢性低血壓引起昏眩而跌倒。

(14)教導適度運動及休息，以增加身體對活動的耐受力。

(15)提供慢性腎衰竭需長期洗腎病人及家屬適當的心理支持。

(16)提供急性腎衰竭病人足夠的水分，以維持腎血流。

(17)教導病人有關血液透析及腹膜透析的知識。

(18)注意因血清電解質不平衡引起的症狀及徵象，例如：意識改變、心電圖變化。

(19)依醫囑給予低劑量 Dopamine，以維持腎血流量和尿輸出量。

(20)依醫囑給予利尿劑治療。

3. 活動耐力不足/與冠狀動脈供血不良、身體氧氣供需失衡導致疲倦有關：

(1)活動前、後測量生命徵象，並比較，必要時監測心電圖改變。

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/8

(2)測量體重。

(3)安排營養師給予飲食諮詢，並監測病人進食之質與量。

(4)每日協助教導自行翻身及執行關節運動。

(5)抬高床頭。

(6)協助採漸進性活動。

(7)討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求並發展個別化及漸進式的活動。

(8)依醫囑服用藥物可促進活動的耐力。

(9)向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子。

(10)教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。

(11)教導病人心臟代償的警訊。

(12)教導當引起疼痛或疲累時，便終止或減少活動。

(13)教導監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。

(14)判斷病人或配偶是否有性諮商的需要，適時給予資訊。

4.易受傷害/與注射抗凝劑有關：

(1)解釋易出血與注射抗凝劑有關，教導病人耐心接受治療並注意減少出血危險性的事項：

A.避免挖鼻孔和擤鼻涕。

B.使用軟毛牙刷，避免傷害牙齦。

C.避免任何引起創傷的情況，例如劇烈活動、與粗糙面的摩擦。

D.執行侵入性治療，例如抽血時，應延長壓迫止血時間，至完全止血為止。

(2)監測生命徵象、意識狀態之變化及出血表徵。

(3)監測生化檢驗值及凝血功能，包括 Hb，APTT，PT 等。

(4)評估且去除病人的危險因子：精神狀況、活動時之耐力。

(5)評估去除環境的危險因子：

A.當病人臥床時，隨時圍上床欄。

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/8

B. 病床輪子固定。

C. 採漸進式活動。

D. 穿不會滑的拖鞋，並鼓勵至少一位家屬隨時陪伴病人。

E. 告知家屬及病人如何使用呼叫鈴。

(6)指導有關出血的預防和症狀評估。

(7)告知病人及家屬對於早期出血的處理方法。

A. 平躺休息，不要亂動。

B. 壓迫出血處。

C. 儘快通知醫護人員處理。

(七) 衛教指導

1. 給予「心肌梗塞之介紹」之衛教單張。

2. 給予「心臟病人的運動復建計畫」衛教單張。

3. 給予「心導管檢查的介紹」之衛教單張。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 謝春蘭、高碧霞、蔡文惠、謝玉娟、吳玉玲、歐育珊等(2019)・急重症護理學・

永大。

(二) 汪文華、劉傳捷、吳淑芳、羅亦渝、林季宜、李梅琛(2020)・冠心症病人心理

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/8

健康、社會支持與健康自我管理之相關性・北市醫學雜誌，(印製中)，1-11。

(三) 林婉如、謝宜庭、謝春滿、黃惠滿 (2024)・一位急性冠心症併發肺水腫病人之急診照護經驗・若瑟醫護雜誌，18(1)，75-86。

七、附件

(略)

主題名稱	急性冠心病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1.內容審閱修正。 2.醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.5	第三項第四目之 2 治療名稱修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。

主題名稱	急性冠心症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B07	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	3.6	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 新增第六項參考資料。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.7	1. 第三項第五、六目護理問題修訂。 2. 第三項第七目衛教指導新增。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.8	第三項第五、六目護理問題修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.9	1. 第三項第三目第 6 點英文修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。